



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
KOMITE PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RS PRIMA HUSADA
MALANG**

TAHUN 2026

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PERSETUJUAN

Program PMKP
Rumah Sakit Prima Husada Malang
Tahun 2026

Program PMKP ini dibuat sebagai rencana kerja PMKP selama tahun 2026.
Peningkatan mutu adalah program yang disusun secara objektif dan sistematis untuk membantu menilai mutu serta kepatuhan kinerja staf dalam memberikan asuhan pada pasien di setiap unit kerjanya.

Disusun oleh:
Komite Mutu RS Prima Husada Malang

Malang, 17 Desember 2025

Disetujui oleh:
Direktur PT Disa Prima Medika



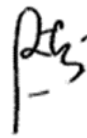
dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

LEMBAR PENGESAHAN

Program Kerja Komite PMKP
Rumah Sakit Prima Husada Malang
Tahun 2026

Disusun oleh:

Ketua Komite PMKP Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ari Putriani, Sp.PK

Disetujui oleh:

Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

Ditetapkan oleh:

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Program Kerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Malang dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Program Kerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Malang disusun sebagai upaya untuk terselenggaranya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta standart akreditasi.

Program ini akan dievaluasi kembali dan akan dilakukan apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi Rumah Sakit Prima Husada Malang. Kami mengucapkan terima kasih kepada piha pihak yang dengan segala upaya telah berhasil menyusun program ini yang merupakan kerjasama dengan berbagai pihak.

Malang, 17 Desember 2025

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien dan menjamin keselamatan pasien maka rumah sakit Prima Husada Malang perlu mempunyai program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) yang menjangkau ke seluruh unit kerja di rumah sakit Prima Husada Malang.

Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang/divisi medis, keperawatan, penunjang medis, administrasi, dan lainnya termasuk kepala unit/departemen/ instalasi pelayanan. Rumah sakit telah menetapkan komite PMKP untuk mengelola program peningkatan mutu dan keselamatan pasien agar mekanisme koordinasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan lebih baik.

Program ini menjelaskan pendekatan yang komprehensif untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berdampak pada semua aspek pelayanan. Pendekatan ini mencakup:

1. Setiap unit terlibat dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
2. Rumah sakit menetapkan tujuan mengukur seberapa baik proses kerja dilaksanakan
3. Validasi datanya menggunakan data secara efektif dan fokus pada tolok ukur program; dan
4. Bagaimana menerapkan dan mempertahankan perubahan yang telah menghasilkan perbaikan.

Agar peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan baik, Direktur Rumah Sakit, para kepala bidang/divisi, serta kepala unit dan departemen di rumah sakit:

1. Wajib mendorong pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP);
2. Berupaya mendorong pelaksanaan budaya mutu dan keselamatan (*patient safety culture*);
3. Secara proaktif melakukan identifikasi dan menurunkan variasi;
4. Menggunakan data agar fokus kepada prioritas isu;
5. Berupaya menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

- 1.2.1** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.2** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran
- 1.2.3** Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 1.2.4** Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
- 1.2.5** Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko
- 1.2.6** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)
- 1.2.7** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
- 1.2.8** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter

dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah

- 1.2.9** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 1.2.10** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 1.2.11** Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.12** Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit 2024
- 1.2.13** Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 1.2.14** Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada Malang secara berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Prima Husada Malang.

1.3.2 Tujuan

1. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang sesuai dengan standar indikator yang ada
2. Meningkatkan keselamatan pasien melalui pelaporan insiden dan penerapan sasaran keselamatan pasien
3. Tersedianya SDM yang profesional dan berkualitas
4. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan medis yang memadai
5. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk karyawan, pasien dan pengunjung rumah sakit

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :
“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

2.3 Motto

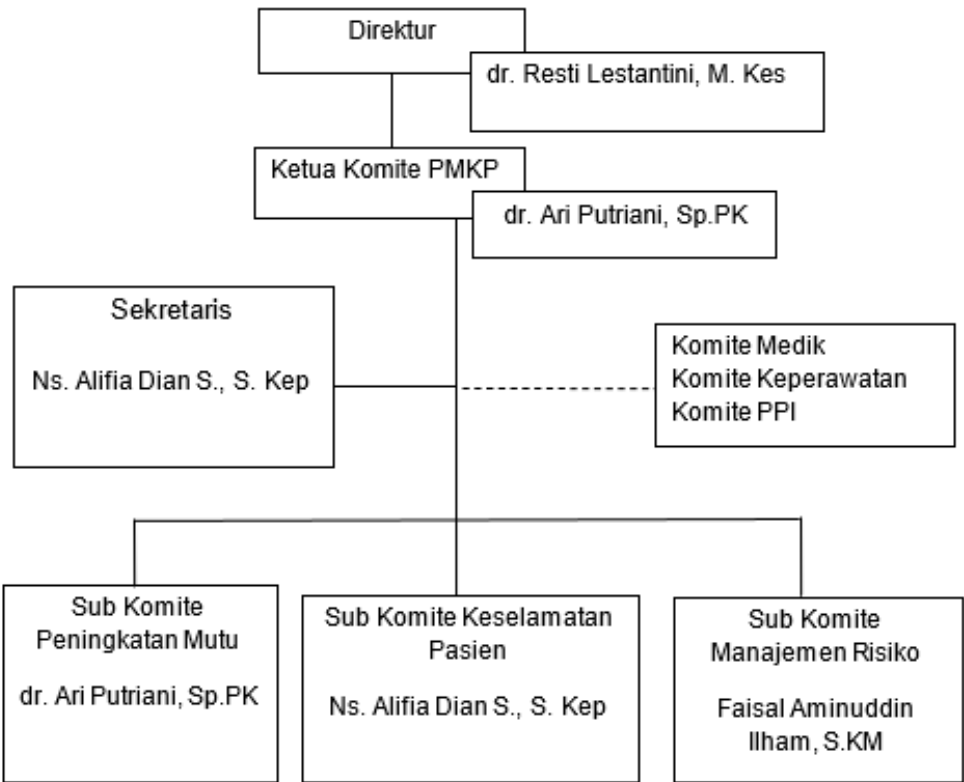
“Sahabat Menuju Sehat”

2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur dan dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK Komite PMKP



BAB III
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN POKOK

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Pengukuran Mutu Indikator termasuk INM, IMP RS dan IMP Unit (a)	1) Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Nasional 2) Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit 3) Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit 4) Melakukan validasi data pada indikator mutu sesuai standard dan kebutuhan 5) Melakukan benchmarking Dan Membuat kajian data hasil perbandingan (benchmarking)
2.	Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan (b)	1) Melakukan Penerapan siklus PDSA (<i>Plan-Do-Study-Action</i>) pada indikator yang tidak mencapai target. 2) Melakukan Evaluasi keberhasilan tindak lanjut perbaikan (apakah perbaikan, bertahan/ stagnan).
3.	Mengurangi varian dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol dan melakukan pengukuran dengan <i>clinical pathway</i> (c(c)	1) Melakukan Pengukuran PPK- <i>Clinical Pathway</i> . 2) Melakukan evaluasi hasil pengukuran CP 3) Memberikan feedback melalui Rapat koordinasi antara Komite PMKP, Komite Medik, dan Bidang Keperawatan dari hasil evaluasi CP untuk meminimalkan varian asuhan
4.	Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM (d)	1) Memilih dan mengukur 1 proyek prioritas perbaikan baik dampak perbaikan primer dan sekunder (terhadap misal: ALOS, keuangan, SDM dll) yang dapat menunjukkan efisiensi dan efektifitas sumber daya. 2) Melakukan perbaikan hasil pengukuran 1 proyek prioritas yaitu IMPRS klinis dan ujicoba perbaikan mutu yang berkesinambungan
5.	Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien (e)	1) Membuat laporan : (laporan bulanan, triwulan tahunan), untuk INM dikirim ke kemenkes 2) Melakukan Penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel). 3) Melaksanakan analisis inside sampai RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) untuk insiden signifikan 4) Melaksanakan pelaporan berkala ke KNKP (Komite Nasional Keselamatan Pasien).
6.	Penerapan sasaran keselamatan pasien (f)	1) Melakukan pengukuran penerapan 6 sasaran Keselamatan pasien yaitu : Identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, kepastian lokasi operasi, pengurangan risiko infeksi, dan risiko jatuh. 2) Melakukan Ronde keselamatan pasien secara berkala.
7.	Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen (g)	1) Melakukan evaluasi mutu layanan yang diberikan oleh pihak ketiga (misal: Laboratorium luar, Outsourcing, Dokter Tamu) 2) Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) dalam setiap kontrak kerja sama jika ada yang vendor baru

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
8.	Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien (h)	1) Melakukan Pelatihan PMKP 2) Melaksanakan Pelatihan Pengambilan Data Mutu (PIC): - Materi: - Indikator Mutu yang diukur di Unit - Alur Pengumpulan Data Mutu di SIMRS - Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan - Praktik mengumpulkan data Mutu di SIMRS <i>by name PIC Data</i> 3) Pelatihan terkait pengisian evaluasi CP di Unit: (Kolaborasi dengan Komite) - Sasaran: PPA (Program Pemberi Asuhan) yakni DPJP, Perawat, Bidan, Gizi dan Farmasi - Materi: - Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit - Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>
9	Mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu meliputi masalah mutu dan capaian data kepada staf	1) Sosialisasi hasil capaian mutu kepada seluruh staf melalui rapat bulanan, papan pengumuman, atau media internal. 2) Pemberian <i>reward</i> bagi unit dengan capaian mutu terbaik atau pelaporan insiden tertinggi (budaya lapor).
10	Pelaksanaan Pengukuran Budaya Keselamatan	1) Pelaksanaan survei budaya keselamatan minimal setahun sekali. 2) Analisis area yang masih rendah (misal: <i>non-punitive response</i>) dan edukasi staf. 3) Laporan ke Direktur dan PT. DPM (Pemilik). 4) Penyusunan program budaya keselamatan untuk tahun berikutnya
11	Pelaksanaan Pengukuran Manajemen Risiko	1) Penyusunan daftar risiko RS. 2) Membuat Profil risiko RS 3) Memilih satu proses berisiko tinggi untuk dilakukan analisis proaktif (FMEA). 4) Evaluasi kepatuhan terhadap mitigasi risiko yang telah disusun.

3.2 Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	Pengukuran Mutu Indikator termasuk INM, IMP RS dan IMP Unit						
1)	Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) 1. Kepatuhan kebersihan tangan 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri 3. Kepatuhan identifikasi pasien 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi 5. Waktu tunggu rawat jalan 6. Penundaan operasi elektif 7. Kepatuhan waktu visite dokter 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional 10. Kepatuhan terhadap alur klinis 11. (<i>Clinical Pathway</i>) 12. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh 13. Kecepatan waktu tanggap komplain Kepuasan pasien	Membandingkan Capaian kepatuhan RS dengan standard	Unit pelayanan	INM	1. (≥ 85%) 2. (100%) 3. (100%) 4. (>80%) 5. (≥ 80%) 6. (<5%) 7. (≥ 80%) 8. (100%) 9. (≥ 80%) 10. (≥ 80%) 11. (100%) 12. (≥ 80%) 13. (76.61%)	Indikator Nasional Mutu terlaksana dengan data riil dan sesuai dengan kondisi lapangan	
2)	Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMPRS) a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP : 6) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas (1) c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko		Unit pelayanan	IMPRS	Target sesuai masing-masing indikator	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit terlaksana dengan data riil dan sesuai dengan kondisi lapangan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
3)	Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)		Setiap Unit di Rumah Sakit	IMP Unit	Target sesuai masing-masing indikator	Indikator Mutu Prioritas RS terlaksana dengan data riil dan sesuai dengan kondisi lapangan	
4)	Melakukan validasi data sesuai standar dan kebutuhan	Menjamin objektivitas dan kebenaran data sebelum dipublikasikan	1. Validator Data Unit 2. Komite 3. Direktur	Validasi data	a. Pengukuran Indikator mutu baru; b. Bila data akan dipublikasi ke masyarakat baik melalui website rumah sakit atau media lain c. Ada perubahan pada pengukuran yang selama ini sudah dilakukan, misalnya perubahan profil indikator, instrumen	Berita acara validasi data tersedia	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
					pengumpulan data, proses agregasi data, atau perubahan staf pengumpul data atau validator d. Bila terdapat perubahan hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya e. Bila terdapat perubahan sumber data, misalnya terdapat perubahan sistem pencatatan pasien dari manual ke elektronik; f. Bila terdapat perubahan		

[illegible]

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1)	Melakukan Pengukuran PPK-Clinical Pathway.	Menilai sejauh mana PPA patuh terhadap panduan klinis	DPJP & Perawat	Audit klinis	Bulanan	Dokumen audit CP tersedia	
2)	Melakukan evaluasi hasil pengukuran CP		Komite			Laporan audit CP	
3)	Memberikan feedback melalui Rapat koordinasi antara Komite PMKP, Komite Medik, dan Bidang Keperawatan dari hasil evaluasi CP untuk meminimalkan varian asuhan	Mencari solusi atas kendala lapangan yang menyebabkan varian asuhan	Komite Medik , Keperawatan, KTKL	Rakor	Triwulan	UMANDOK	
4.	Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM						
1)	Memilih dan mengukur 1 proyek prioritas perbaikan baik dampak perbaikan primer dan sekunder (terhadap misal: ALOS, keuangan, SDM dll) yang dapat menunjukkan efisiensi dan efektifitas sumber daya.	Membuktikan bahwa peningkatan mutu mengurangi pemborosan (waste)	Unit Prioritas	Analisis	100% IMPRS	Bukti adanya efisiensi Sumberdaya	
2)	Melakukan perbaikan hasil pengukuran 1 proyek prioritas yaitu IMPRS klinis dan ujicoba perbaikan mutu yang berkesinambungan	Mengintegrasikan laporan klinis dengan performa finansial RS	Manajemen Keuangan	Koordinasi	Tahunan	Laporan korelasi mutu-biaya	
5.	Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien						
1)	Membuat laporan: INM dikirim ke kemenkes	Mempertanggungjawabkan kinerja Mutu	Komite	Laporan			
2)	Melakukan penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel).	Memudahkan staf dalam melaporkan insiden tanpa rasa takut (<i>No Blame</i>)	Seluruh Unit		Real-time		

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
3)	Melaksanakan telusur insiden sampai RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) untuk insiden signifikan	Menemukan akar masalah insiden serius untuk perbaikan sistem	Tim RCA	Telusur	Sesuai aturan batas waktu Kejadian	Tersedianya laporan telusur insiden keunit dan UMANDOK RCA	
4)	Melaksanakan pelaporan berkala ke KNKP (Komite Nasional Keselamatan Pasien). Penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel)	Mempertanggungjawabkan kinerja Mutu	Sub Komite Keselamatan Pasien	Investigasi	Max 45 Hari	Laporan RCA & bukti input ke aplikasi KNKP	
6.	Penerapan sasaran keselamatan pasien						
1)	Melakukan pengukuran penerapan 6 sasaran Keselamatan pasien yaitu: Identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, kepastian lokasi operasi, pengurangan risiko infeksi, dan risiko jatuh.	Memastikan identifikasi, komunikasi, obat, operasi, infeksi, & jatuh aman	Pasien & PPA	Observasi	Bulanan	Laporan bulanan kepatuhan SKP	
2)	Melakukan Ronde keselamatan pasien secara berkala	Melihat langsung penerapan standar keselamatan di lapangan	Direksi & Komite PMKP	Supervisi	Minimal 1x/bulan	Temuan ronde ditindaklanjuti oleh unit	
7.	Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen						
1)	Melakukan evaluasi mutu layanan yang diberikan oleh pihak ketiga (misal: Laboratorium luar, Outsourcing, Dokter Tamu) .	Memastikan kendali mutu vendor telah dilaksanakan	Penunjang Medis	Audit	100% Mitra	Laporan evaluasi berkala	
2)	Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) dalam setiap kontrak kerja sama jika ada yang vendor baru	Menstandarisasi indikator kmutu dalam tiap dokumen kontrak	PT DPM	MOU	100% Kontrak	Klausul mutu/KPI tercantum dalam PKS	
8.	Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien						
1)	Melakukan Pelatihan PMKP dengan Materi:	Meningkatnya pemahaman serta keterampilan terkait	All Staff	Sosialisasi & Pelatihan	100% karyawan	1. 100% karyawan mengikuti pelatihan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	a) Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b) Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan Pasien c) Manajemen Resiko	program PMKP di RS Prima Husada				2. 100% staf mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan	
2)	Melaksanakan Pelatihan Pengambilan Data Mutu dengan materi : 1) Kamus Indikator Mutu yang diukur di Unit 2) Alur Pengumpulan Data Mutu di <i>Google Spreadsheet</i> 3) Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4) Praktik mengumpulkan data Mutu baik di <i>SIMRS by name PIC Data</i>	Meningkatnya Keterampilan PIC-data tentang materi yang akan diberikan dalam Diklat PIC-data	PIC Data unit	Diklat internal	1 kali dalam setahun 100% PIC data	Semua PIC dapat mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasi indikator mutu unit nya	
3)	Pelatihan terkait pengisian evaluasi CP di Unit: dengan Materi: 1) Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2) Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>	Meningkatnya Keterampilan peserta diklat tentang materi yang akan diberikan dalam Diklat evaluasi CP	1. Karu, 2. PJ shift 3. MPP	Diklat internal	1 kali dalam setahun Evaluasi CP berjalan 100%	100% evaluator mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan Evaluasi CP jalan	
9	Komunikasi hasil pengukuran mutu kepada staf						
1)	Sosialisasi capaian mutu (rapat bulanan, papan pengumuman, media internal)	Memastikan data mutu tersampaikan secara visual dan verbal kepada staf	Seluruh Unit Kerja	Sosialisasi	Tanggal 15 tiap bulan	Terpasangnya visualisasi data (grafik) di area staf	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
2)	Pemberian <i>reward</i> bagi unit dengan capaian mutu terbaik atau pelaporan insiden tertinggi (budaya lapor)	Memotivasi unit untuk terus berprestasi dan berani melaporkan insiden	Unit Kerja & Individu	Apresiasi	Semesteran / Tahunan	Meningkatnya jumlah laporan insiden dan kepatuhan data	
10	Pelaksanaan Pengukuran Budaya Keselamatan						
1)	Pelaksanaan survei budaya keselamatan minimal setahun sekali	Mengumpulkan data persepsi keamanan dan dukungan manajemen dari staf	Medis & Non-Medis	Survei	Min. 80% Responden	Kuesioner (AHRQ) terisi lengkap	
2)	Analisis area rendah (misal: <i>non-punitive</i>) dan edukasi staf	Memperbaiki dimensi budaya yang lemah agar staf berani melapor tanpa rasa takut	Unit dengan Skor Rendah	Perbaikan	Sesuai hasil survei	Adanya bukti sosialisasi/edukasi tindak lanjut	
3)	Laporan ke Direktur dan PT. DPM (Pemilik)	Memberikan laporan komprehensif kepada pimpinan untuk dukungan kebijakan	Direksi & Pemilik	Manajerial	Semesteran/ Tahunan	Laporan tertulis diterima & didisposisi	
4)	Penyusunan program budaya keselamatan tahun berikutnya	Merancang strategi penguatan budaya berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan	Komite PMKP & SDM	Perencanaan	Desember 2026	Dokumen program kerja budaya keselamatan baru	
11.	Pengukuran Manajemen Risiko						
1)	Penyusunan daftar risiko (<i>Risk Register</i>) di seluruh unit	Mendokumentasikan semua potensi risiko klinis maupun non-klinis	Kepala Unit & PJ Mutu	Administrasi	Januari - Maret	Tersedianya dokumen <i>Risk Register</i> Unit	
2)	Memilih satu proses berisiko tinggi untuk dilakukan analisis proaktif (FMEA)	Menganalisis titik lemah pada proses pelayanan yang paling kritis	Tim FMEA / Unit Terkait	Investigasi	1 Dokumen/tahun	Laporan FMEA lengkap dengan desain ulang proses	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
3)	Evaluasi kepatuhan terhadap mitigasi risiko yang telah disusun	Memastikan langkah pencegahan yang direncanakan benar-benar dijalankan	Unit Kerja	Monitoring	Triwulanan	Checklist mitigasi terisi dan risiko terkendali	

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1.	Pengukuran Mutu Indikator termasuk INM, IMP RS dan IMP Unit						
1)	Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM) 1. Kepatuhan kebersihan tangan 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri 3. Kepatuhan identifikasi pasien 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi 5. Waktu tunggu rawat jalan 6. Penundaan operasi elektif 7. Kepatuhan waktu visite dokter 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional 10. Kepatuhan terhadap alur klinis 11. (<i>Clinical Pathway</i>) 12. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh 13. Kecepatan waktu tanggap komplain Kepuasan pasien	Melakukan pengumpulan data harian dan rekapitulasi bulanan	Observasi & Analisis Statistik	Spreadsheet	Setiap Bulan	Laporan Capaian Mutu & Hasil Validasi Data	
2)	Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMPRS) 1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP : 6) 2. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas (1) 3. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) 4. Indikator terkait Perbaikan Sistem a. Indikator terkait Manajemen Risiko	Melakukan pengumpulan data harian dan rekapitulasi bulanan	Observasi & Analisis Statistik	Spreadsheet	Setiap Bulan	Laporan Capaian Mutu & Hasil Validasi Data	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
3)	Melakukan Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP Unit)	Melakukan pengumpulan data harian dan rekapitulasi bulanan	Observasi & Analisis Statistik	Spreadsheet	Setiap Bulan	Laporan Capaian Mutu & Hasil Validasi Data	
4)	Melakukan validasi data sesuai standard dan kebutuhan	Melakukan cek silang antara pengumpul data dan validator pada indikator baru	Verifikasi Data	Lembar Validasi	Tiap Triwulan	Berita Acara Validasi Data	
5)	Melakukan <i>benchmarking</i> Dan Membuat kajian data hasil perbandingan (<i>benchmarking</i>)	Membandingkan data capaian dengan standar atau RS lain secara statistik	Analisis Komparatif	Grafik Tren (Run Chart)	Tiap Triwulan	Laporan Analisis & Rekomendasi	
2.	Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan						
1)	Penerapan siklus PDSA (<i>Plan-Do-Study-Action</i>) pada indikator yang tidak mencapai target	Melakukan uji coba perbaikan pada indikator yang tidak mencapai target	Siklus PDSA	Form PDSA	Sesuai Hasil Capaian	Dokumen PDSA & Laporan Evaluasi	
2)	Evaluasi keberhasilan tindak lanjut perbaikan (apakah perbaikan bertahan/stagnan)	Memantau apakah hasil PDSA memberikan dampak peningkatan capaian	Monitoring & Evaluasi	Lembar Observasi / Dashboard Mutu	Tiap Triwulan	Laporan Evaluasi Pasca Perbaikan	
3	Mengurangi varian dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol dan melakukan pengukuran dengan <i>clinical pathway</i>						
1)	Melakukan Pengukuran PPK- <i>Clinical Pathway</i> .	Melakukan audit kepatuhan PPA terhadap panduan praktik klinis	Audit Medis	Lembar Audit CP	Setiap Bulan	Laporan Audit CP & Notulen Koordinasi	
2)	Melakukan evaluasi hasil pengukuran CP	Pengumpulan data, tabulasi data, membuat grafik, analisis, PDSA RTL/rekomendasi	Laporan	PC	Tiap bulan	CP dilaksanakan sesuai jumlah sampel	
3)	Memberikan feedback melalui Rapat koordinasi antara Komite PMKP, Komite Medik, dan Bidang Keperawatan dari hasil evaluasi CP untuk meminimalkan varian asuhan	Membuat undangan rapat, menyiapkan materi rapat , pelaksanaan rapat membuat notulen, laporan	Rapat, Diskusi	Luring	Triwulan	Respon dari Komite profesi Pelayanan sesuai PPK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
4	Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM						
1)	Memilih dan mengukur 1 proyek prioritas perbaikan baik dampak perbaikan primer dan sekunder (terhadap misal: ALOS, keuangan, SDM dll) yang dapat menunjukkan efisiensi dan efektivitas sumber daya.	Identifikasi proyek prioritas , melakukan pengukuran, analisis, PDSA, dintegrasikan dengan Sbr daya , melakukan perhitungan efisiensinya	Analisis Dampak Keuangan	Laporan Keuangan & Mutu	Tahunan	Laporan Efisiensi (Cost-Benefit Analysis)	
2)	Melakukan perbaikan hasil pengukuran 1 proyek prioritas yaitu IMPRS klinis dan ujicoba perbaikan mutu yang berkesinambungan	Rapat koordinasi Komite PMKP, Medik, & Keperawatan	Analisis	Rapat Koordinasi	Undangan & Notulen	Tiap Semester	
5	Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien						
1)	Membuat laporan : IKP dikirim ke kemenkes	a. Melakukan pengumpulan data capaian indikator mutu dari seluruh unit sesuai periode pelaporan. b. Melakukan verifikasi dan validasi data yang telah dikumpulkan. c. Melakukan analisis capaian indikator dan menyusun interpretasi hasil pengukuran. d. Melakukan pelaporan indikator nasional mutu melalui sistem pelaporan Kementerian Kesehatan sesuai jadwal yang ditentukan	Laporan, PDCA, PDSA	PC	Setiap bulan	Monitoring Pelaporan di website	
2)	Melakukan Penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel).	a. Melakukan sosialisasi alur pelaporan insiden keselamatan pasien kepada seluruh staf.	Investigasi (RCA)	Aplikasi KNKP / Form IKP	Real-time	Laporan Insiden & Laporan RCA	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		b. Memastikan ketersediaan formulir atau media pelaporan insiden yang mudah diakses. c. Melakukan pendampingan kepada unit dalam pelaksanaan pelaporan insiden. d. Melakukan monitoring kepatuhan pelaporan insiden di seluruh unit pelayanan. e. Melakukan evaluasi efektivitas alur pelaporan dan perbaikan bila diperlukan.					
3)	Melaksanakan telusur insiden sampai RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) untuk insiden signifikan	a. Melakukan identifikasi dan verifikasi insiden signifikan yang memerlukan analisis mendalam. b. Membentuk tim analisis insiden sesuai ketentuan rumah sakit. c. Melakukan investigasi dan pengumpulan data terkait kejadian insiden. d. Melaksanakan analisis akar masalah menggunakan metode Root Cause Analysis. e. Menyusun rekomendasi tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil RCA. f. Melakukan monitoring implementasi rekomendasi perbaikan.	Melakukan investigasi sederhana s/d mendalam sesuai	Root Cause Analysis	Jika ada kasus	Max 45 hari pasca insiden	
4)	Melaksanakan pelaporan berkala ke KNKP (Komite Nasional Keselamatan Pasien).Penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel)	a. Mengumpulkan data insiden keselamatan pasien yang wajib dilaporkan. b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan validitas data laporan insiden.	Laporan	Internet/aplikasi	Tiap bulan	Tertera dalam aplikasi KNKP	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		c. Menyusun laporan insiden sesuai format pelaporan KNKP. d. Menginput dan mengirimkan laporan secara berkala melalui sistem pelaporan yang ditetapkan. e. Mendokumentasikan bukti pelaporan sebagai arsip rumah sakit. f. Melakukan tindak lanjut atas umpan balik dari KNKP apabila ada.					
6.	Penerapan sasaran keselamatan pasien						
1)	Melakukan pengukuran penerapan 6 sasaran Keselamatan pasien yaitu : Identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, kepastian lokasi operasi, pengurangan risiko infeksi, dan risiko jatuh.	a. Unit melakukan pengukuran 6 SKP bersama validator b. Unit melaporkan hasil pengukuran melalui SIMRS c. Komite merekap hasil laporan unit untuk dilaporkan bulanan d. Melakukan analisis dan menyusun PDSA dan RTL sesuai hasil pengukuran	Observasi	SIMRS	Setiap hari sesuai unit	Laporan pengukuran SKP	
2)	Melakukan Ronde keselamatan pasien secara berkala	a. Menyusun jadwal ronde keselamatan pasien secara berkala bersama tim terkait. b. Melakukan kunjungan lapangan jajaran Direksi untuk melihat budaya keselamatan c. Mendokumentasikan temuan hasil ronde keselamatan pasien. d. Menyampaikan umpan balik langsung kepada unit terkait atas temuan yang didapatkan. e. Menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut atas temuan ronde keselamatan pasien.	Observasi Langsung	Checklist Ronde SKP	Minimal 1x setiap bulan	Laporan Temuan Ronde & Tindak Lanjut	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		f. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil ronde secara berkala.					
7.	Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen						
1)	Melakukan evaluasi mutu layanan yang diberikan oleh pihak ketiga (misal: Laboratorium luar, Outsourcing, Dokter Tamu) .	a. Mengidentifikasi pihak ketiga yang menjadi objek evaluasi mutu layanan. b. Menetapkan indikator evaluasi mutu sesuai jenis layanan yang diberikan. c. Melakukan pengumpulan data capaian mutu melalui audit, monitoring, dan telaah laporan pelayanan. d. Melakukan analisis kesesuaian capaian layanan terhadap standar atau target yang telah ditetapkan. e. Mengidentifikasi kendala atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan layanan. f. Menyusun hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kepada pihak ketiga terkait. g. Melakukan tindak lanjut dan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan hasil evaluasi.Membuat laporan ke Dir-RS	Audit & Review	Lembar Evaluasi Kontrak	Tiap Semester	Hasil Evaluasi Vendor & Notulen Review	
2)	Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) dalam setiap kontrak kerja sama jika ada yang vendor baru	a. Melakukan identifikasi ruang lingkup layanan yang akan dikerjasamakan dengan vendor baru. b. Menentukan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur sesuai jenis layanan.	Review Kontrak	Dokumen PKS	Tiap Semester	Lampiran KPI pada Dokumen PKS	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		c. Menyusun target capaian KPI berdasarkan standar mutu rumah sakit dan ketentuan yang berlaku. d. Melakukan pembahasan KPI bersama pihak vendor sebelum penandatanganan kontrak. e. Memastikan klausul mutu tercantum dalam perjanjian kerjasama (PKS) f. Melakukan sosialisasi KPI kepada unit terkait sebagai dasar monitoring pelaksanaan kontrak. g. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian KPI vendor sebagai dasar penilaian kinerja					
8.	Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien						
1)	Melakukan Pelatihan PMKP dengan Materi: a. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan Pasien c. Manajemen Risiko	a. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan PMKP bagi seluruh staf sesuai hasil evaluasi program mutu. b. Menyusun materi pelatihan sesuai kebijakan, standar akreditasi, dan kebutuhan rumah sakit. c. Menetapkan jadwal, narasumber, dan peserta pelatihan PMKP. d. Melaksanakan pelatihan PMKP kepada seluruh staf sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. e. Melakukan evaluasi pemahaman peserta melalui pre-test, post-test, atau evaluasi praktik.	Ceramah tanya jawab role play Game-simulasi	PPT , sound, LCD, laptop	1x dalam setahun	TUMANDOK sertifikat	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		f. Mendokumentasikan hasil pelatihan sebagai bahan monitoring kompetensi staf.					
2)	Melaksanakan Pelatihan Pengambilan Data Mutu dengan materi : a. Kamus Indikator Mutu yang diukur di Unit b. Alur Pengumpulan Data Mutu di SIMRS c. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS <i>by name PIC Data</i>	a. Menetapkan PIC mutu unit sebagai peserta pelatihan pengambilan data. b. Menyusun materi pelatihan terkait definisi operasional indikator dan tata cara pengumpulan data. c. Memberikan pelatihan teknis pengisian, pencatatan, dan pelaporan data mutu sesuai format yang ditetapkan. d. Melaksanakan simulasi pengambilan dan input data mutu. e. Melakukan evaluasi kompetensi peserta dalam pengambilan data. f. Melakukan pendampingan pasca pelatihan untuk memastikan ketepatan pelaksanaan di unit.	Ceramah tanya jawab role play Praktik simulasi	PPT , sound, LCD, laptop	1x dalam setahun	TUMANDOK sertifikat	
3)	Pelatihan terkait pengisian evaluasi CP di Unit: dengan Materi: 1) Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2) Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>	a. Menyusun materi pelatihan pengisian formulir evaluasi Clinical Pathway. b. Menetapkan peserta pelatihan dari unit pelayanan yang melaksanakan Clinical Pathway. c. Memberikan penjelasan terkait tata cara pengisian, kelengkapan data, dan kriteria evaluasi Clinical Pathway. d. Melaksanakan praktik simulasi pengisian evaluasi Clinical Pathway.	Ceramah tanya jawab Roll play praktek	PPT , sound, LCD, laptop	1x dalam setahun	TUMANDOK sertifikat	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		e. Melakukan evaluasi hasil pemahaman peserta terhadap pengisian evaluasi CP. f. Melakukan monitoring dan pendampingan pelaksanaan pengisian evaluasi CP di unit secara berkala.					
9.	Komunikasi hasil pengukuran mutu kepada staf						
1)	Sosialisasi capaian mutu (rapat bulanan, papan pengumuman, media internal)	a. Mengumpulkan dan menyusun hasil capaian indikator mutu dari seluruh unit secara periodik. b. Melakukan analisis data capaian mutu untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. c. Menyusun materi sosialisasi dalam bentuk laporan, grafik, atau media informasi lainnya. d. Menyampaikan hasil capaian mutu melalui rapat bulanan, papan pengumuman, atau media internal rumah sakit. e. Memberikan penjelasan terkait hasil capaian, kendala, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. f. Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi sebagai bukti komunikasi hasil mutu kepada seluruh staf.	Sosialisasi	Rapat Rutin	Sekali dalam sebulan	UMANDOK & Foto Publikasi Data	
2)	Pemberian <i>reward</i> bagi unit terbaik dan budaya lapor tertinggi	a. Menetapkan kriteria penilaian pemberian reward berdasarkan	Penilaian berdasarkan capaian indikator mutu dan	Sertifikat penghargaan	Tahunan	UMANDOK penetapan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		capaian indikator mutu atau kepatuhan pelaporan insiden. b. Melakukan rekapitulasi dan verifikasi data capaian dari seluruh unit. c. Melakukan penilaian unit berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. d. Menetapkan unit penerima reward melalui rapat evaluasi bersama tim terkait. e. Memberikan penghargaan kepada unit terpilih dalam forum resmi rumah sakit. f. Melakukan publikasi hasil pemberian reward sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan budaya mutu dan keselamatan pasien.	jumlah pelaporan insiden, penetapan pemenang melalui rapat evaluasi PMKP, pemberian penghargaan pada forum resmi rumah sakit			pemenang, sertifikat.	
10.	Pelaksanaan Pengukuran Budaya Keselamatan						
1)	Pelaksanaan survei budaya keselamatan	a. Menyusun kuesioner/instrument survey budaya keselamatan b. Menetapkan jadwal dan sasaran pelaksanaan survei budaya keselamatan pasien c. Melakukan sosialisasi kepada seluruh staf mengenai tujuan dan tata cara pengisian survei. d. Melaksanakan penyebaran kuesioner survei kepada seluruh staf rumah sakit.	Survei	Kuesioner (Google Form)	1x dalam setahun	Laporan Analisis Budaya Keselamatan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
2)	Analisis area rendah (misal: <i>non-punitive</i>) & edukasi staf	a. Melakukan analisis hasil survei budaya keselamatan b. Mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan c. Melakukan <i>brainstorming</i> pada dimensi budaya keselamatan yang lemah	Analisis data, brainstorming, sosialisasi, edukasi terfokus	Sosialisasi Unit	Pasca Survei	Bukti Sosialisasi & Materi Perbaikan	
3)	Pelaporan hasil ke Direktur dan PT. DPM (Pemilik)	a. Menyusun laporan hasil survei budaya keselamatan b. Melakukan analisis dan interpretasi hasil survei c. Memaparkan hasil survei budaya untuk mendapatkan dukungan manajerial	Presentasi Laporan	Laporan Tertulis	Tahunan	Tanda Terima Laporan & Notulen Paparan	
4)	Penyusunan program budaya keselamatan tahun berikutnya	a. Mengidentifikasi area/dimensi yang memerlukan perbaikan b. Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan evaluasi budaya keselamatan	Perencanaan	Dokumen Program	Desember 2026	Draf Program Kerja Mutu 2027	
11.	Pengukuran Manajemen Risiko						
1)	Penyusunan daftar risiko (<i>Risk Register</i>) di seluruh unit	a. Melakukan identifikasi risiko pada setiap unit kerja b. Melakukan penilaian tingkat risiko, c. Menetapkan tindakan mitigasi d. Menyusun dan memperbarui Risk Register unit.	Identifikasi & Analisis Risiko	Form Risk Register	November-Desember	Dokumen Risk Register	
2)	Analisis proaktif proses berisiko tinggi (FMEA)	a. Memilih proses berisiko tinggi yang menjadi prioritas b. Membentuk tim FMEA c. Melakukan analisis potensi kegagalan dan dampaknya	Diskusi Tim FMEA	Form FMEA	1x dalam setahun	UMANDOK, Laporan FMEA	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		d. Menyusun rekomendasi tindakan pencegahan.					
3)	Evaluasi kepatuhan terhadap mitigasi risiko	a. Melakukan monitoring pelaksanaan tindakan mitigasi yang telah ditetapkan dalam Risk Register b. Mengevaluasi kepatuhan unit terhadap rencana mitigasi c. Menyusun rekomendasi tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian.	Monitoring Kepatuhan	Lembar Monitoring	Tiap semester	Lembar Monitoring, Laporan Hasil Evaluasi, Notulen Rapat Tindak Lanjut	

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Melakukan pengukuran INM,IMPRS,IMP Unit																	
1)	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM).		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Unit	PIC data Unit	PT.DPM	
2)	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
3)	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
4)	Validasi Data		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sesuai kondisi	Karu		

5)	Benchmarking		√			√			√			√			RS lain, Kemenkes Jurnal	Komite PMKP	PT DPM	
2.	Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan																	
1)	Penerapan siklus PDSA (<i>Plan-Do-Study-Action</i>) pada indikator yang tidak mencapai target selama 3 bulan berturut-turut		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sesuai hasil capaian	Komite PMKP	PT DPM	
2)	Evaluasi keberhasilan tindak lanjut perbaikan (apakah perbaikan bertahan/stagnan)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP		
3	Mengurangi varian dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol dan melakukan pengukuran dengan <i>clinical pathway</i>																	
1)	Melakukan Pengukuran PPK- <i>Clinical Pathway</i> .		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Unit	Karu, MPP	PT DPM	
2)	Melakukan evaluasi hasil pengukuran CP														RS	Komite PMKP	PT DPM	
3)	Memberikan feedback melalui Rapat koordinasi antara Komite PMKP, Komite Medik, dan Bidang Keperawatan dari hasil evaluasi CP untuk meminimalkan varian asuhan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R.rapat	Komite PMKP	PT DPM	
4	Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM																	
1)	Memilih dan mengukur 1 proyek prioritas perbaikan baik dampak perbaikan primer dan sekunder (terhadap misal: ALOS, keuangan, SDM dll) yang dapat menunjukkan													√		Komite PMKP	PT DPM	

	efisiensi dan efektifitas sumber daya.																	
2)	Melakukan perbaikan hasil pengukuran 1 proyek prioritas yaitu IMPRS klinis dan ujicoba perbaikan mutu yang berkesinambungan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP	PT DPM	
5	Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien																	
1)	Membuat laporan : INM dikirim ke kemenkes	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R kerja Mutu di RS	Komite PMKP	PT DPM	
2)	Melakukan Penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel).	SDM dan Komite PMKP								√					R. rapat		PT DPM	
3)	Melaksanakan telusur insiden sampai RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) untuk insiden signifikan	Tim RCA													Sesuai kasus		PT DPM	
4)	Melaksanakan pelaporan berkala ke KNKP (Komite Nasional Keselamatan Pasien).Penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel)	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R kerja Mutu di RS	Komite PMKP	PT DPM	
6.	Penerapan sasaran keselamatan pasien																	
1)	Melakukan pengukuran penerapan 6 sasaran Keselamatan pasien yaitu : Identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, kepastian lokasi operasi,	Unit pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	PT DPM	-

	pengurangan risiko infeksi, dan risiko jatuh.																	
2)	Melakukan Ronde keselamatan pasien secara berkala	Semua PPA dan Komite	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	PT DPM	-
7	Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen																	
1)	Melakukan evaluasi mutu layanan yang diberikan oleh pihak ketiga (misal: Laboratorium luar, Outsourcing, Dokter Tamu) .	Unit yang bekerjasama dengan pihak ke 3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	SDM, Laboratorium, TPS	Karu Kabid	PT DPM	
2)	Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) dalam setiap kontrak kerja sama jika ada yang vendor baru	Pihak ke-3/vendor													Jika ada MoU baru, disalah satu pasal MOU		PT DPM	
8	Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien																	
1)	Melakukan Pelatihan PMKP dengan Materi: a. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan Pasien c. Manajemen Resiko	All staf								√					R diklat	Komite PMKP	PT DPM	
2)	Melaksanakan Pelatihan Pengambilan Data Mutu dengan materi : a. Kamus Indikator Mutu yang diukur di Unit	PIC data unit									√				R Diklat		PT DPM	

[illegible]

1)	Menyusun Risk Register	All Unit												√	R Rapat	Komite K3RS PMKP PPI	PT DPM	-
2)	Analisis FMEA	Komite PMKP												√	Tempat Unit Masing-Masing		PT DPM	-
3)	Monitoring Mitigasi Risiko	Komite PMKP						√						√	Tempat Unit Masing-Masing	Karu Komite	PT DPM	-

1.5 Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah disetujui oleh PT. Disa Prima Medika dengan rincian sebagaimana terlampir :

Tabel 3.5. Kebutuhan biaya pengembangan SDM Komite PMKP tahun 2026

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	Eksternal	2	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
2	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Eksternal	2	Rp 3.500.000	Rp 7.000.000
3	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Eksternal	1	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
4	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Malang	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000
5	<i>Refreshment & Training PMKP</i> Materi: a. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien c. Budaya Keselamatan d. Manajemen Resiko	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000
7	Pelatihan Pengambilan Data Mutu	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
	Materi: a. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit b. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS c. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS e. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS				
8	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: a. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit b. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000
9	Honorarium narasumber pelatihan insidentil (DPJP) 4 kali pelatihan x 4 org DPJP	Eksternal	20	Rp 250.000	Rp 5.000.000
TOTAL					Rp 24.200.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

1.1. Monitoring

Sesuai dengan Permenkes No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, kegiatan monitoring Komite PMKP dilakukan dalam bentuk:

1. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan program mutu di unit kerja
2. Monitoring, supervisi dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu
3. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja
4. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja

1.2. Evaluasi

Sesuai dengan Permenkes No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, kegiatan evaluasi Komite PMKP dilakukan dalam bentuk:

1. Rapat rutin dengan PIC Data Unit terkait capaian indikator mutu unit setiap bulan
2. Rapat Triwulanan dengan Kepala Ruang dan Jajaran Manajemen terkait capaian indikator mutu, insiden keselamatan pasien yang ada di unit
3. Pemberian masukan dan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit terkait perbaikan mutu tingkat Rumah Sakit
4. Rapat pemilihan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit dan pengukuran indikator tingkat Rumah Sakit serta menindaklanjuti hasil capaian indikator
5. Rapat pemilihan risk register unit dengan Kepala Ruang, Seluruh Komite dan jajaran Manajemen untuk dilakukan profil register.
6. Motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien
7. Melakukan Root Cause Analysis (RCA) dan pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien
8. Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali oleh bidang bagian dan dianalisa setiap triwulan, untuk di berikan rekomendasi dan di sampaikan kepada Pemilik (Direktur PT)
9. Setelah ada feedback maka disampaikan melalui direktur ke Komite PMKP, Komite PMKP menyampaikan feedback kepada manajer untuk ditindak lanjuti

BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Kegiatan pengumpulan data indikator mutu di lakukan oleh PIC data unit dengan menggunakan SIMRS
2. Data yang dikumpulkan diverifikasi oleh kepala instalasi dan dilihat apakah sudah sesuai dengan profil indikator atau belum.
3. Setiap capaian indikator di rekapitulasi setiap bulan, dilengkapi dengan analisa dan tindak lanjut.
4. Setiap tiga bulan, data tersebut direkap dan dianalisis oleh manajer menjadi laporan triwulan sebagai bentuk evaluasi unit.
5. Komite PMKP bertugas melakukan validasi data hasil kegiatan jika hasil kegiatan jika ada data yang harus dievaluasi sesuai kebutuhan dalam prosedur validasi.
6. Setelah data valid maka laporan dari hasil analisa analisa setiap unit direkap menjadi laporan hasil kegiatan rumah sakit, Direktur RS melaporkan kepada Direktur PT Pemilik RS
7. Setelah ada Feedback dari Direktur PT Pemilik RS kepada Direktur RS maka disosialisasikan kepada semua manajer untuk penyusunan tindak lanjut dan diinformasikan kepada semua staf diunit kerja.
8. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dari setiap kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan, hasil evaluasi disampaikan oleh Komite PMKP dan diserahkan ke Direktur PT Pemilik RS untuk ditindaklanjuti.

BAB VI
PENUTUP

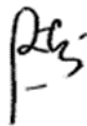
Demikian program kerja Komite PMKP disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang tahun 2026. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program kerja yang sudah disusun.

Menyetujui,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestianti, M.Kes

Malang, 17 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Komite PMKP

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ari' followed by a stylized flourish.

dr. Ari Putriani, Sp.PK